Az Érzelem-Stressz-Viselkedés modell empirikus tesztelése

Egy kérdőíves pilotvizsgálat eredményei

Szerző: Ódor Antal, független kutató

DOI: 10.5281/zenodo.18069510

ID: https://orcid.org/0009-0009-2027-3245

odor.antal@mozgasjavito.com

Budapest, 2025

Absztrakt

A jelen tanulmány az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) modell empirikus tesztelésére tett kísérletet kérdőíves pilotvizsgálat formájában. A modell szerint a pszichés működés az érzelmi állapotok, a stresszreakciók és a testi tünetek dinamikus kölcsönhatásában értelmezhető. A mintában (N=13) négy skálát használtunk: STAI (A_t), DERS (P_t), PSS (H_t) és PHQ-15 (C_t). A Pearson-féle korrelációs elemzés eredményei szignifikáns összefüggést mutattak a szorongás, érzelemszabályozás és stressz között, miközben a pszichoszomatikus tünetek csak korlátozott módon kapcsolódtak ezekhez a komponensekhez. Az eredmények alátámasztják az ESV modell központi téziseit, ugyanakkor további vizsgálatokat tesznek szükségessé.

Bevezetés

Az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) modell integratív pszichobiológiai keretrendszer, amely a limbikus rendszer aktivitását és az érzelem-, stressz- és viselkedési minták egyensúlyát tekinti kulcsfontosságú komponenseknek a mentális egészség szempontjából. A modell hipotézise szerint ezen elemek egyensúlyvesztése vezet pszichés zavarokhoz, mint például függőségek, pszichoszomatikus betegségek vagy ambivalencia.

Módszer

A vizsgálatban 13 fő (8 nő, 5 férfi, életkor: 21-75 év, átlagéletkor: 48,6 év) vett részt, akik önkéntes alapon online töltötték ki a kérdőíveket egy névtelen, strukturált Google Forms felületen keresztül. A résztvevők különböző társadalmi és foglalkozási háttérrel rendelkeztek, ami biztosította az alapszintű heterogenitást. A kutatás célja az volt, hogy az ESV modell elméleti összefüggései mérhető formában is vizsgálhatók-e kérdőíves módszertannal.

Az alkalmazott mérőeszközök

STAI - Állapotszorongás (A_t): Az aktuális érzelmi állapotot, különösen a szorongást méri.

DERS - Érzelemszabályozás (P_t): A résztvevő érzelmi önszabályozó képességét vizsgálja.

PSS - Perceived Stress Scale (H_t): Az elmúlt hetekben észlelt stressz-szintet méri.

PHQ-15 - Pszichoszomatikus tünetek (C_t): A testi tünetek gyakoriságát vizsgálja pszichés összefüggésben.

Az adatok elemzéséhez Pearson-féle korrelációs együtthatókat számoltunk, valamint kétmintás T-próbákat végeztünk a lehetséges eltérések feltárására. A statisztikai szignifikanciaszintet $p < 0.05$-ben határoztuk meg.

Eredmények

A pontos korrelációs és p-érték eredmények a következők:

párosítás	korrelációs együttható (r)	p-érték
A_t - P_t	-0.647	0.031
A_t - H_t	0.614	0.031
A_t - C_t	0.575	0.044
P_t - H_t	-0.773	0.005
P_t - C_t	-0.262	0.064
H_t - C_t	0.346	0.437

Korrelációs mátrix

	A_t	P_t	H_t	C_t
A_t	1	-0.647122246342411	0.614401613503148	0.575248180802875
P_t	-0.647122246342411	1	-0.772763878386157	-0.261587950039472
H_t	0.614401613503148	-0.772763878386157	1	0.345877872116384
C_t	0.575248180802875	-0.261587950039472	0.345877872116384	1

T-próba

	A_t	P_t	H_t	C_t
A_t	-	-2.54643460867845	2.33614721466126	2.10976649690436
P_t	-2.54643460867845	-	-3.65261532613381	-0.813075426251386
H_t	2.33614721466126	-3.65261532613381	-	1.10588963171486
C_t	2.10976649690436	-0.813075426251386	1.10588963171486	-

P-érték

	A_t	P_t	H_t	C_t
A_t	-	0.0313777600022696	0.0442989267014823	0.064094070932604
P_t	0.0313777600022696	-	0.0052959502529957	0.437154551435992
H_t	0.0442989267014823	0.0052959502529957	-	0.297457862308376
C_t	0.064094070932604	0.437154551435992	0.297457862308376	-

A szorongás szignifikáns kapcsolatban áll mind a stressz (H_t), mind a testi tünetek (C_t) szintjével. Az érzelemszabályozás zavara szoros kapcsolatot mutat a megélt stresszel, és mérsékelt, de nem szignifikáns kapcsolatban van a pszichoszomatikus tünetekkel. A stressz-tünet összefüggés nem bizonyult statisztikailag szignifikánsnak.

Megbeszélés

Az adatok alátámasztják az ESV modell központi hipotézisét: az érzelmi zavarok és stresszreakciók szoros kapcsolata mérhető, és az önszabályozási nehézségek fokozzák a pszichés terhelést. A testi tünetekkel való kapcsolat gyengébb, de a tendencia megfelel a pszichoszomatikus irodalom előfeltevéseinek. A résztvevők életkori változatossága lehetővé teszi az intergenerációs mintázatok vizsgálatát is, ami jövőbeli kutatási irányokat vet fel.

Következtetés

A pilotvizsgálat alapján az ESV modell kérdőíves operacionalizálása megbízhatónak tűnik, és előzetes empirikus támaszt nyújt az elméleti kerethez. A nagyobb mintás, longitudinális kutatások segíthetik annak mélyebb megértését, hogyan alakulnak az érzelem-stressz-testi tünetek közötti kapcsolatok az élet során.

Irodalomjegyzék

Ódor, A. (2023). *Függőségek mechanizmusa.* Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18063294

Ódor, A. (2020). *Ambivalencia.* Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18062030

Ódor, A. (2024). *Az ESV-Modell: Az Érzelem-Stressz-Viselkedés kapcsolata a függőségek mechanizmusában.* Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18067060

Ódor, A. (2024). *Pszichés kényszerhurok: Egy trauma-indukált mentális mechanizmus dinamikája.* Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18067292

Ódor, A. (2025). *Az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) modell: Egy integrált pszichobiológiai rendszerelméleti megközelítés az emberi működés megértéséhez.* Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18069155

ESV-25 inventory

Ez a kérdőív az érzelmi állapotod jelenlegi dinamikájának feltárására szolgál az ESV-modell négy fő komponense alapján:

A(t) – Amygdala aktivitás (Szorongás)

P(t) – Prefrontális kontroll (Önszabályozás)

H(t) – HPA-tengely aktiváció (Stresszérzés)

C(t) – Kortizolszint proxy (Testi tünetek)

Küldés gomb lenyomásával elfogadod az általad kitöltött kérdőív feldolgozását, későbbiekben történő felhasználását.

* Kötelező kérdés

1. Születési dátum *

Példa: 2019. január 7.

2. Legmagasabb iskolai végzettség * Dropdown

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

- Általános iskola
- Szakképzés
- Középiskolai végzettség
- Gimnázium
- Felsőfokú képesítés

3. Város *

4. Neme *

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

- férfi
- nő

5. **A(t)** *

Idegesnek érzem magam

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

	1	2	3	4	5	
egyá						nagyon

6. Aggódom valami miatt *

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

	1	2	3	4	5	
egyá						nagyon

7. Úgy érzem, nem tudok megnyugodni *

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

	1	2	3	4	5	
egyá						nagyon

8. Ingerlékeny vagyok *

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

	1	2	3	4	5	
egyá	◯	◯	◯	◯	◯	nagyon

9. Képtelen vagyok ellazulni *

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

	1	2	3	4	5	
egyá	◯	◯	◯	◯	◯	nagyon

10. Nyugtalan vagyok, nem tudok koncentrálni *

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

	1	2	3	4	5	
egyá	◯	◯	◯	◯	◯	nagyon

11. **P(t)** *

Gyakran cselekszem impulzívan, amikor erős érzelmeim vannak

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

	1	2	3	4	5	
egyá	◯	◯	◯	◯	◯	teljes mértékben igaz

12. Nehezemre esik megnyugodni, amikor felzaklat valami *

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

	1	2	3	4	5	
egyá	◯	◯	◯	◯	◯	teljes mértékben igaz

13. Ha stresszes vagyok, nehezen gondolkodom világosan *

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

	1	2	3	4	5	
egyá	◯	◯	◯	◯	◯	teljes mértékben igaz

14. Néha nem tudom, mit érzek *

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

	1	2	3	4	5	
egyá	◯	◯	◯	◯	◯	teljes mértékben igaz

15. Képtelen vagyok úgy irányítani az érzelmeimet, ahogyan szeretném *

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

	1	2	3	4	5	
egyá	◯	◯	◯	◯	◯	teljes mértékben igaz

16. Ha rosszul érzem magam, gyakran túlságosan lekötnek ezek az érzések *

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

	1	2	3	4	5	
egyá	◯	◯	◯	◯	◯	teljes mértékben igaz

17. **H(t)** *

Úgy érzem, hogy nem tudok megbirkózni a fontos dolgaimmal

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

	1	2	3	4	5	
sohá	◯	◯	◯	◯	◯	nagyon gyakran

18. Úgy érzem, túl sok stressz ér egyszerre *

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

	1	2	3	4	5	
sohá	◯	◯	◯	◯	◯	nagyon gyakran

19. Úgy érzem, elvesztem az irányítást az életem felett *

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

	1	2	3	4	5	
sohá	◯	◯	◯	◯	◯	nagyon gyakran

20. Úgy érzem, hogy túlfeszülök, és nem tudok leállni *

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

	1	2	3	4	5	
soha	◯	◯	◯	◯	◯	nagyon gyakran

21. **C(t)** *

Fáradtság, kimerültség

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

	0	1	2	
egyá	◯	◯	◯	nagyon

22. Fejfájás *

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

	0	1	2	
egyá	◯	◯	◯	nagyon

23. Szívdobogásérzés *

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

	0	1	2	
egyá	◯	◯	◯	nagyon

24. Alvászavar *

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

	0	1	2	
egyá	◯	◯	◯	nagyon

25. Hasi diszkomfort, fájdalom vagy puffadás *

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

	0	1	2	
egyá	◯	◯	◯	nagyon

Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá.

Google Űrlapok

Az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) modell terepi alkalmazása gyógypedagógiai környezetben

Módszertani beszámoló

Szerző: Ódor Antal, független kutató

DOI: 10.5281/zenodo.18076570

ID: https://orcid.org/0009-0009-2027-3245

odor.antal@mozgasjavito.com

Budapest, 2025. augusztus 26. - október 11.

Absztrakt

A tanulmány egy öthetes, intenzív terepmunka tapasztalatait összegzi, amelynek célja az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) modell gyakorlati validációja volt egy gyógypedagógiai intézmény alsó tagozatos, speciális nevelési igényű tanulókat integráló csoportjában. Az ESV-modell a mentális működést dinamikus, funkcionális egyensúlyvesztésként értelmezi, és a tüneti beavatkozás helyett a rendszer önszabályozó képességének helyreállítására fókuszál. A terepi megfigyelések és kvalitatív jegyzetek alapján a módszer különösen hatékonynak bizonyult a traumatikus hiány, a dezorganizált kötődés és a tanult patológiás minták kezelésében. A beavatkozások gyors és stabil csoportszintű változást eredményeztek, az önszabályozás, a bizalom és a koregulációs készségek terén.

Bevezetés

A gyógypedagógiai gyakorlatban egyre gyakoribb, hogy a segítők komplex érzelmi, viselkedési és traumaalapú problémákkal küzdő gyermekekkel dolgoznak. A hagyományos tünetorientált megközelítések (pl. DSM, BNO) statikus kategóriákban gondolkodnak, amelyek kevéssé tükrözik az egyéni pszichés folyamatok dinamikáját. Az ESV-modell egy funkcionális, rendszerszintű keret, amely szerint minden viselkedés érzelmi (E) és stressz-eredetű (S) tényezők kölcsönhatásából (V) születik. A modell célja, hogy a pedagógus, gyógypedagógus és mentálhigiénés segítő a viselkedés mögötti folyamatokat értse meg és ezekre reagáljon, nem csupán a tünetre.

Módszertan

A terepi szakasz egy öthetes, kvalitatív jellegű megfigyelésen alapult. A kutatási helyszín egy gyógypedagógiai intézmény alsó tagozata volt, ahol a tanulók többsége valamilyen fejlődési, érzelmi vagy kötődési nehézséggel küzdött. Az adatgyűjtés terepi naplók, reflektív jegyzetek és intervenciós leírások formájában történt. A tanulmány nem tartalmaz semmilyen beazonosítható személyes adatot, minden esettípus összevont, anonimizált formában jelenik meg. A kutatás kvalitatív és feltáró jellegű volt, célja a modell gyakorlati alkalmazhatóságának és hatékonyságának validálása terepi környezetben.

Eredmények és beavatkozási típusok

A traumatikus hiány kezelése

A szülői veszteségből fakadó érzelmi hiány gyakran agresszív vagy orális (pl. fokozott evés) viselkedésben jelent meg. Az ESV-intervenció itt a biztonságos érzelemkifejezés új rítusának tanítását célozta, amely lehetőséget adott a hiány megélésére és korrekciójára. Az érzelemnevesítés („hiányzik valaki", „szomorú vagyok") és a fizikai koreguláció kombinációja gyors javulást eredményezett az agresszió és feszültségszint csökkenésében.

Dezorganizált kötődés pedagógiai keretezése

Az ambivalens kötődési mintázatot mutató gyermekeknél a direkt szeretet paradox módon stresszt generált. Az áttétel-alapú beavatkozás során a pedagógus irányított érzelmi expozíciót hozott létre, amelyben a gyermek biztonságosan élhette meg a dühöt és veszteséget. A kapcsolat megtartása a düh után korrekciós élményként működött, és jelentős kötődési stabilizálódást eredményezett.

Tanult patológiás minták megszakítása

Az instrumentális, tanult viselkedések esetében (pl. üvöltés, mint eszköz) az ún. egó-trigger technika hozott áttörést. A „kihívásnyelv" („Biztos, hogy csak ennyit tudsz?") aktiválta a kompetenciaérzést, így megszakadt a pszichés kényszerhurok, a viselkedés önfenntartó jellege.

A modell hatékonyságának indikátorai

- Gyors rendszer-stabilizálódás: A korábban kaotikus, szétesős csoportdinamika 2-3 hét alatt önszabályozó rendszerré alakult.
- Szétesések megszűnése: A viselkedéses kontrollvesztések jelentősen ritkultak, több esetben teljesen megszűntek.
- Önszabályozás megjelenése: A gyerekek egy része képes lett az érzelem- és stresszkezelésre külső segítség nélkül.
- Autentikus érzelemkifejezés: A destruktív viselkedések helyét fokozatosan valódi, elfojtott érzelmek (pl. sírás, bújás, bocsánatkérés) vették át.

Megbeszélés

A terepi tapasztalatok alapján az ESV-modell nem csupán intervenciós módszer, hanem diagnosztikai keret is. A viselkedés értelmezése az érzelem-stressz tengelyen keresztül rendszerszintű szemléletet biztosít, amely a gyógypedagógiai munkát kiterjeszti az érzelmi edukáció és a stresszreguláció irányába. A modell különlegessége, hogy a koregulációt - vagyis a segítő és gyermek közötti közös érzelmi szabályozást - tanítható, tudatos folyamatként kezeli. Ezáltal a pedagógus nem csak viselkedésformáló, hanem érzelmi mintázatkorrekciót végző segítővé válik. Az eredmények alátámasztják, hogy a modell alkalmazása jelentősen gyorsabb stabilizálódást eredményez, mint a hagyományos viselkedésirányító technikák.

Konklúzió

Az öthetes terepi vizsgálat tapasztalatai alapján az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) modell a gyógypedagógiai gyakorlatban magas hatékonyságú, rövid távon is eredményt mutató megközelítés. Az ESV-modell nem helyettesíti a pszichológiai vagy orvosi ellátást, hanem kiegészíti azt a pedagógiai térben. A további kutatásoknak kvantitatív irányban kell folytatódniuk, a modell hosszú távú hatékonyságának statisztikai validálására.

Hivatkozások

Bowlby, J. (1969). *Attachment and loss: Vol. 1. Attachment*. Basic Books.

Ódor, A. (2020). *Ambivalencia*. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18062030

Ódor, A. (2024). *Az ESV-Modell: Az Érzelem-Stressz-Viselkedés kapcsolata a függőségek mechanizmusában*. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18067060

Ódor, A. (2024). *Pszichés kényszerhurok: Egy trauma-indukált mentális mechanizmus dinamikája*. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18067292

Schore, A. N. (2003). *Affect regulation and the repair of the self*. W. W. Norton & Company.

Siegel, D. J. (2012). *The developing mind: How relationships and the brain interact to shape who we are*. Guilford Press.

Van der Kolk, B. A. (2014). *The body keeps the score: Brain, mind, and body in the healing of trauma*. Viking.